KLINIČKI PUT

ATREZIJA EZOFAGUSA

Ime (ime oca) i prezime pacijenta		Bolnički broj
Datum rođenja:		Tel:
JMBG:	Spol M ☐ Ž ☐	E-mail:
Članovi porodice: Tel:		

Datum i vrijeme prijema:	Alergije

Uputstvo za popunu obrasca – kliničkog puta / opis kliničkog puta

Svi članovi osoblja dužni su upisati ime, prezime i potpisati se na označenom mjestu, po okončanju aktivnosti za koju su zaduženi. Pored izvršene aktivnosti stavlja se kvačica kao dokaz ili zaokružuje odgovor Da ili Ne. Na nekim mestima potrebno je upisati podatak.

Vrijeme obavljanja aktivnosti se upisuje samo ukoliko se ocijeni da je od značaja da se aktivnosti obave u određeno vrijeme ili u određenim intervalima.

Klinički put se u okviru mogučnosti oslanja na kliničke dokaze. Gdje oni ne postoje, on se oslanja na najbolju kliničku praksu. Unatoč tome klinički put je uputstvo i nije nepromjenljiv. Odstupanje se definiše kao skretanje sa kliničkog puta koje treba razmotriti na narednom sastanku zato što može dovesti do izmjene kliničkog puta ili se od člana tima može zahtijevati da promijeni svoj način rada. Odstupanja treba da su predmet periodične evaluacije tima. Značajno odstupanje se obavezno upisuje u obrazac. Unosi se datum i vrijeme odstupanja i upiše napomena, zašto je došlo do odstupanja. U zavisnosti od prirode odstupanja upisuje se i završetak.

Kod svakog pregleda ispunjavaju se sve kolone anamneze i fizikalnog pregleda.

Ime i prezime pacijenta _____

Uputstvo za pacijente

ATREZIJA JEDNJAKA

Atrezija jednjaka predstavlja prekid kontinuiteta jednjaka, sa postojenjem dva slijepa kraja, gornjeg i donjeg. Najčešća vrsta ove anomalije je kada proksimalni kraj jednjaka završava poput slijepe vreće, a distalni komunicira sa račvištem traheje. Atreziju jednjaka nalazimo u 1 : 3000 poroda, a uzrokovana je poremećajem razvoja traheoezofagealnog septuma. Postoje različite podijele atrezije jednjaka. Najprihvatljivija je i vrlo jednostavna podijela po Grossu:
1.TIP „A“ AE bez fistule (8%),
2 TIP „B“.AE sa proksimalnom traheoezofagealnom fistulom(0,8%),
3.TIP „C“AE sa distalnom traheoezofagealnom fistulom (86,5%),
4.TIP „D“ AE sa proksimalnom i distalnom fistulom (0,7%),
5.TIP „H“ Traheo-ezofagusna fistula bez atrezije (4%)
6. TIP „F“ Urođena stenoza jednjaka (1 %)

Klinička slika

Prvi znak koji upućuje na atreziju jednjaka je polihidramnion majke, prenatalno dijagnostikovan, kao i nemogućnost ultrasonografskog prikazivanja fetalnog želudca. Odmah poslije rođenja pojavljuje se obilje pjenušave pljuvačke, koja se izlijeva iz usta. Istovremeno mogu se javiti zagrcavanje, kašalj, dispnea i cijanoza, naročito ako se pokuša sa hranjenem bebe, što je već znak kašnjena dijagnostike. U ovakvim slučajevima, respiratorni distres sve je evidentniji, epizode cijanoze sve su češće, a neuspješni pokušaji hranjena još više pogoršavaju stanje djeteta.

Dijagnoza i liječenje

Rana dijagnoza prije hranjena mora biti obavezan cilj. Kad god postoji klinička sumnja, prije prvog hranjena pokušati plasiranje nazogastrične sonde u želudac. Ukoliko postoji AE obično se na 10-12 cm od gingiva –nosa osjeti otpor. Sonda se fiksira u tom položaju, aspirira se sadržaj. Ubaci se malo kontrasta, te napravi radiografija u dva pravca. Prisustvo odnosno odsutsvo gasa u abdomenu demonstrira postojanje, odnosno nepostojanje TEF od čega zavisi strategija hirurškog liječenja. Na istom snimku se analizira stanje na plućima i traže druge udružene anomalije(atrezija duodenuma, atrezija crijeva, skeletne anomalije).
Operativni zahvat je vrlo težak(jednjak nema serozu, eventualno veća distanca krajeva jednjaka, postojanje upale pluća itd), a mortalitet je visok. Operacijom se nastoji uspostaviti kontinuitet jednjaka u jednom postupku. Postoperativni tok je vrlo zahtijevan.

Skraćenice upotrijebljene u kliničkom putu

AE	**Atrezija ezofagusa**	**TEF**	**Traheo-ezofagealna fistula**
NG	**Nazogastrična sonda**	**EHO**	**Ehosonografija**
PT	**Porođajna težina**		
AP	**Antero-posteriorni**		
RTG	**Rentgen**		

Ime i prezime pacijenta _____

Osoblje/Učesnici u kliničkom putu

IME I PREZIME	POZICIJA	DATUM	TELEFON	POTPIS I INICIJALI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Ime i prezime pacijenta _____
_____

Algoritam kliničkog puta

SUMNJA NA ATREZIJU EZOFAGUSA

↓

KLASIFIKACIJA PO GROSU:
1.TIP „A“ AE bez fistule (8%),
2 TIP „B“.AE sa proksimalnom traheoezofagealnom fistulom(0,8%),
3.TIP „C“AE sa distalnom traheoezofagealnom fistulom (86,5%),
4.TIP „D“ AE sa proksimalnom i distalnom fistulom (0,7%),
5.TIP „H“ Traheo-ezofagusna fistula bez atrezije (4%)
6. TIP „F“ Urođena stenoza jednjaka (1 %)

↓

Inicijalna evaluacija:

- Anamneza
- Fizikalni pregled
- RTG grudnog koša (AP profil i bočni) i sa kontrastom
- Uspostavljanje položaja sa podignutom glavom
- Kontroliranje temperature
- Plasiranje NG sonde u proksimalni bataljak i stavljanje na permanentnu sukciju
- Antibiotici koji će pokriti gram pozitivnu i gram negativnu floru
- Uzeti bris grla i nosa

↓

KLASIFIKACIJA RIZIČNIH GRUPA PO WATERSTONU:

↓	↓	↓
PT> 2,5 kg i zdrava novorođenčad	PT 2-2,5 kg i /ili dobra PT uz srednje teške srčane anomalije(ASD,VSD), ali umjereno izraženi znaci pneumonije	PT < 2 kg ili veća PT Uz teže urođene srčane anomalije i/ ili teža pneumonija
↓	↓	↓
HITNA PRIMARNA OPERATIVNA REKONSTRUKCIJA	ODLOŽNA PRIMARNA REKONSTRUKCIJA	ETAPNO ZBRINAVANJE

Ime i prezime pacijenta _____

Klinički put – ATREZIJA EZOFAGUSA

Kliničke aktivnosti	Prvi pregled						2. Kontrolni pregled		
	Datum		ostala anamneza:						
Anamneza	da	ne	Porodična anamneza	da	ne		da	ne	
Pojava veće količine pljuvačke u ustima			Podaci o hidramnionu,polihidramnionu						
Zagrcavanje			Udružene anomalije						
Kašalj			Kardiovaskularne anomalije						
Regurgitacija			Skeletno vertebralne anomalije						
Peribukalna cijanoza			Digestivne anomalije						
Hromozomske aberacije			Genitourinarne anomalije						
			CNS anomalije			Potpis ljekara i medicinske sestre			Potpis ljekara i medicinske sestre
			VATER/VACTERLanomalije						

Fizikalni pregled	Opis:
Abdomena	
Grudnog koša	
Pokušaj plasiranja nazogastrične sonde	

Pretrage						
Lab.pretraga	Vrijednost	Vrijednost	Vrijednost	Vrijednost	Vrijednost	Vrijednost
KKS		kreatinin		Proteinogram		
CRP		APTT				
urin		INR				
šuk		jonogram				
urea		ABS				

Radiološke pretrage	Opis:
RTG grudnog koša(AP profil i bočni)	
RTG grudnog koša sa kontrastom	
Eho abdomena i bubrega	
Eho mozga	
Eho srca	

Dijagnoza	

Ime i prezime pacijenta _____

Terapija	Naziv lijeka	Doziranje	Trajanje terapije
Operativni zahvat			

Edukacija	
Usmena uputstva	
Pisana uputstva	
Putem telefona	

Postignuti ciljevi	

Komentar		
Potpis ljekara I medicinske sestre	Med.sestra/tehničar:	Ljekar:

Odjeljak za navođenje odstupanja od kliničkog puta